

**SURAT EDARAN
NOMOR: 451/RSPHS/I-SE/DIR/VIII/2026**

**TENTANG
KETENTUAN PEMBERIAN OBAT KRONIS PADA PASIEN PESERTA JKN**

Dalam rangka meningkatkan ketertiban administrasi pelayanan dan klaim JKN, mencegah terjadinya fragmentasi pelayanan, serta memastikan kesesuaian pemberian obat kronis dengan ketentuan penjaminan, maka perlu ditetapkan ketentuan pemberian obat kronis pada pasien peserta JKN sebagai berikut:

1. Pasien Kronis Kondisi Stabil : Pasien dengan diagnosis kronis yang memiliki kondisi klinis stabil dapat dilakukan **Program Rujuk Balik (PRB)** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Pasien Kronis yang Memerlukan Evaluasi Terapi :
 - a. Pasien dengan diagnosis kronis yang masih memerlukan evaluasi terhadap kondisi klinis dan obat kronis dapat diberikan obat untuk kebutuhan **maksimal 7 (tujuh) hari** dan diperhitungkan dalam paket **INA-CBG**
 - b. Apabila berdasarkan hasil evaluasi kondisi pasien dengan pemberian obat 7 hari telah stabil, maka pemberian obat kronis selanjutnya dapat diberikan untuk kebutuhan **1 (satu) bulan** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Kunjungan di Tengah Periode Obat Kronis :
 - a. Pasien yang telah mendapatkan obat kronis untuk kebutuhan **30 (tiga puluh) hari/1 (satu) bulan** tidak diperkenankan melakukan kunjungan rutin
 - b. Apabila pasien mengalami **kondisi akut atau keluhan baru** di tengah periode pemberian obat kronis 30 (tiga puluh) hari, pasien diarahkan terlebih dahulu ke **FKTP** untuk dilakukan asesmen dan penatalaksanaan sesuai kondisi klinis pasien
 - c. Petugas wajib mengkonfirmasi apakah pasien sudah melakukan pemeriksaan di FKTP, apabila pasien belum melakukan pemeriksaan di FKTP maka diarahkan ke FKTP untuk periksa, namun bila pasien sudah melakukan pemeriksaan di FKTP maka petugas melakukan konfirmasi ke pada FKTP.
4. Pemeriksaan Penunjang :
 - a. Apabila pasien memerlukan pemeriksaan penunjang maka dilakukan **sebelum pemberian obat kronis untuk periode 30 (tiga puluh) hari**. (sesuai dengan ketentuan retrisik obat)
 - b. Apabila pasien hanya datang untuk menjalani pemeriksaan penunjang yang merupakan bagian dari rangkaian pelayanan atau evaluasi dari kunjungan sebelumnya, maka pemeriksaan tersebut **diperhitungkan sebagai bagian dari rangkaian pelayanan pada kunjungan sebelumnya** dan tidak dilakukan pemisahan klaim sebagai kunjungan baru, sesuai dengan ketentuan penjaminan yang berlaku.
5. Tindakan Medis pada Pasien Kronis :
 - a. Apabila pasien memerlukan tindakan medis lain, seperti **injeksi intraartikuler**, maka DPJP harus menentukan urgency klinis pasien
 - b. Apabila pasien diberikan obat kronis 30 hr maka tindakan dapat direncanakan setelah periode pemberian obat kronis 30 (tiga puluh) hari berakhir kemudian pasien di PRB kan
 - c. Apabila pasien dilakukan tindakan injeksi intraartikuler terlebih dahulu maka tidak diperkenankan untuk pemberian obat kronis, pemberian obat kronis dapat diberikan setelah terapi injeksi berakhir sesuai dengan ketentuan
 - d. Pasien selanjutnya dapat diarahkan kembali ke **FKTP** untuk dilakukan asesmen dan, apabila terdapat indikasi medis yang harus dirujuk ke RS maka FKTP akan merujuk ke RS

6. Kontrol Pertama Pasca Rawat Inap : Pasien yang melakukan **kontrol pertama setelah rawat inap**, dalam kondisi klinis stabil dan memerlukan obat kronis, maka dapat diberikan obat kronis untuk kebutuhan **maksimal 30 (tiga puluh) hari/1 (satu) bulan**.
7. Pemecahan Kunjungan Poli : Tidak diperkenankan melakukan **pemecahan kunjungan poli** dalam satu rangkaian pelayanan pasien dengan tujuan untuk memperoleh pelayanan atau pengajuan klaim secara terpisah.
8. Dokter dan tenaga kesehatan wajib memperhatikan riwayat kunjungan serta riwayat pemberian obat kronis pasien sebelum memberikan obat kronis berikutnya.
9. Petugas terkait wajib melakukan verifikasi terhadap tanggal kunjungan, tanggal pemberian obat, jumlah obat, serta periode pemakaian obat kronis sebelumnya.

Demikian surat edaran ini dibuat untuk diperhatikan dan dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Pasuruan
Pada Tanggal 01 Agustus 2026
Direktur RS Prima Husada Sukorejo



Ns.Heni Indra Wulansari, S.Kep,M.Kep